SANATORIO ARGENTINO

Innovación y Transformación Digital

Gobernanza Clínica y de Datos

PROYECTO DE GOBERNANZA DE DATOS · GOB-EPI-2026-04

Vigilancia Epidemiológica y Neurocirugía (Dr. Romano)

Automatización de Planilla C2 Ministerial (SNVS 2.0), Curvas Epidémicas por Patología, Control Pediátrico Exacto (<24 Meses) y Actividad Neuroquirúrgica

SERVICIO AUDITADO: Comité de Infectología, Vigilancia Epidemiológica Institucional y Servicio de Neurocirugía / Neurología

ÁREA RESPONSABLE: Sanatorio Argentino - Innovación y Transformación Digital

ESTADO DEL PROYECTO: Activo - 100% Completado | Período de Referencia: Octubre 2026

CASOS VIGILADOS (12 MESES)	PICO INVERNAL (JUN 2026)	CORTE OCTUBRE 2026	INDICADORES DOCUMENTADOS
2.920 Notificaciones	**483 Casos / mes**	**156 Casos Auditados**	**7 Indicadores SQL**
Consolidado Nov 2025 - Oct 2026	240 ETI · 92 Neumonías · 88 Bronq.	72 Resp. · 48 Diarreas · 17 ETS	100% Finalizados (6 Epi + NeuroCx)

1. ¿QUÉ HEMOS HECHO EN EL SERVICIO?

Objetivos alcanzados, módulos desplegados y valor clínico-administrativo para Sanatorio Argentino

Automatización integral de los requerimientos de Vigilancia Epidemiológica de notificación obligatoria (Planilla C2 / Ministerio de Salud) y métricas de Neurocirugía lideradas por el Dr. Romano: detección automática por códigos CIE y texto diagnóstico de Bronquiolitis en menores de 2 años (<24 meses exactos), ETI (Influenza), Neumonías, Diarreas Agudas, Varicela e Infecciones de Transmisión Sexual (ETS/ITS), junto con el monitoreo quirúrgico de Neurocirugía.

1. Automatización de la Planilla C2 de Vigilancia Epidemiológica Obligatoria

Se reemplazó el relevamiento manual de diagnósticos por un motor automatizado que consolida mensualmente y por semana epidemiológica las 6 familias de eventos de notificación obligatoria exigidas por el Ministerio de Salud: (1) Bronquiolitis en menores de 2 años, (2) Enfermedad Tipo Influenza (ETI), (3) Neumonías, (4) Gastroenteritis y Diarreas Agudas, (5) Varicela y (6) Enfermedades de Transmisión Sexual (Sífilis, Gonorrea, Clamidia, VIH, HPV/Condiloma y Herpes genital).

2. Algoritmo de Precisión Etaria Pediátrica (< 24 Meses Exactos al Día de la Consulta)

Para cumplir estrictamente con la definición ministerial de caso de Bronquiolitis (lactantes menores de 2 años), se implementó el cruce automático entre la fecha de la consulta diagnóstica y la fecha de nacimiento del padrón de pacientes, calculando la edad exacta en meses cumplidos al día de la atención.

3. Estratificación por Grupo Etario, Sede de Atención y Auditoría Nominal C2

El tablero clasifica automáticamente cada evento en Lactantes (<2 años), Pediátricos (2 a 14 años) y Adultos (>=15 años), desglosando por centro operativo (Sede Santa Fe, Mitre, San Luis) y ofreciendo un buscador nominal auditable con exportación directa a Excel oficial y Reporte PDF Epidemiológico.

4. Módulo de Trazabilidad de Neurocirugía y Neurología Clínica

Se completó e integró el indicador específico de actividad neuroquirúrgica y neurológica, rastreando todas las intervenciones quirúrgicas codificadas como (CX) y consultas especializadas de los últimos 5 años en SALUS.

2. ¿CÓMO LO HEMOS HECHO? (INGENIERÍA Y CALIDAD DE DATOS)

Extracción desde SALUS SQL Server, reglas de depuración clínica y sincronización con el motor Telar

1 **Fase 1: Mapeo Terminológico Dual (CIE-9 / CIE-10 + Texto Libre Médico)**

Se construyó una matriz SQL sobre [SALUS].[dbo].[TABLEAU_Diagnosticos y motivo consulta] que captura tanto la codificación estructurada (ej. 466.1 / J21.0 para Bronquiolitis; 487 / J10-J11 para Influenza; 480-486 / J15-J18 para Neumonía; 787.91 / A09 para Diarreas; 052 / B01.9 para Varicela; 090-099 / A51-A56 para ETS) como las variantes ortográficas ingresadas por los profesionales.

2 **Fase 2: Cruce Demográfico con VLISE_DatosPaciente**

Se vinculó cada episodio diagnóstico con [SALUS].[dbo].[VLISE_DatosPaciente] mediante el [NHC] único, aplicando DATEDIFF(MONTH, p.FechaNacimiento, t.[Fecha visita]) < 24 como filtro excluyente para el indicador de Bronquiolitis.

3 **Fase 3: Construcción de Curvas Epidémicas Estacionales (Invierno vs Verano)**

Se estructuró la serie continua mensual que permite visualizar con claridad la transición estacional entre el corredor de infecciones respiratorias agudas (pico mayo-julio) y el corredor de gastroenteritis agudas estivales (pico diciembre-febrero).

4 **Fase 4: Generación Automática del Reporte Ministerial en PDF y Excel**

Se integró el generador documental que emite en un clic la planilla consolidada C2 y el anexo nominal de casos confirmados con médico interviniente, código CIE, edad, servicio y destino (internación vs ambulatorio).

3. EJEMPLOS REALES AUDITADOS Y CASOS DE USO (2026)

Demostración práctica con cifras reales de Sanatorio Argentino sobre cómo operar e interpretar cada indicador

Ejemplo Real 1: Curva Epidémica Invernal de Infecciones Respiratorias (Mayo a Julio 2026)

Contexto Clínico / Gestión: El Comité de Control de Infecciones y la Dirección Médica requieren anticipar la demanda de camas pediátricas y de internación clínica durante los meses de frío.

Lectura Detallada del Dato Real: La serie histórica auditada muestra cómo las notificaciones totales pasan de 136 casos en Enero 2026 a un pico máximo de 483 casos en Junio 2026 (+255%). En Junio 2026, los cuadros respiratorios explican el 86,9% de las notificaciones: 240 casos de ETI / Influenza, 92 Neumonías y 88 Bronquiolitis agudas en lactantes menores de 24 meses (seguidos en Julio 2026 por 198 ETI, 79 Neumonías y 72 Bronquiolitis).

Acción y Toma de Decisión: La visualización temprana del ascenso en Abril (266 casos) y Mayo (385 casos) permite activar la contingencia invernal en Guardia Pediátrica y ampliar la disponibilidad de oxigenoterapia de alto flujo en observación.

Ejemplo Real 2: Transición Estacional hacia Gastroenteritis y Vigilancia Continua en Octubre 2026

Contexto Clínico / Gestión: El equipo de Vigilancia Epidemiológica elabora el cierre mensual de Octubre 2026 para su remisión oficial.

Lectura Detallada del Dato Real: Al seleccionar Octubre 2026 en el filtro Telar, el tablero consolida exactamente 156 casos notificados: 49 ETI (Influenza), 48 Diarreas Agudas / Gastroenteritis (evidenciando el repunte primaveral-estival), 23 Neumonías, 17 casos de Enfermedades de Transmisión Sexual (Sífilis precoz A51.0, Clamidia A56.0, Gonococia), 14 Bronquiolitis en menores de 2 años y 5 casos de Varicela (B01.9).

Acción y Toma de Decisión: Con un clic en la tabla nominal, el auditor verifica cada caso (ej. lactantes de 8 y 11 meses con Bronquiolitis J21.0 internados en observación en Sede Santa Fe, o pacientes adultos con Neumonía J15.9 ingresados a piso clínico) y descarga la Planilla C2 lista para firma.

Ejemplo Real 3: Trazabilidad de Procedimientos de Neurocirugía y Neurología

Contexto Clínico / Gestión: El Dr. Romano solicitó disponer en el mismo entorno de gobernanza del volumen real de cirugías neurológicas realizadas y su evolución.

Lectura Detallada del Dato Real: El indicador SQL de Neurocirugía filtra en [VLISE_Visitas con categoria] todas las prestaciones con especialidad NEUROCIRUGIA o NEUROLOGIA, asistencia "Presente" y código de prestación quirúrgica "(CX)%", permitiendo auditar craneoplastías, descompresiones, biopsias estereotáxicas y cirugías espinales de los últimos 5 años.

Acción y Toma de Decisión: Se integra la producción neuroquirúrgica al catálogo oficial con un 100% de completitud técnica.

4. CATÁLOGO DE INDICADORES Y REGLAS DE AUDITORÍA

Inventario completo de requerimientos finalizados, tablas origen en SALUS y lógica de cálculo

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
1. Producción Quirúrgica y Consultas de Neurocirugía y Neurología	SALUS: [VLISE_Visitas con categoria] y [TABLEAU_Cirugias]	Volumen histórico y mensual (últimos 5 años) de intervenciones neuroquirúrgicas codificadas bajo modalidad (CX) y prestaciones asistenciales de Neurocirugía y Neurología con asistencia efectiva en Sanatorio Argentino.	**Finalizado**
2. Indicadores de Gobierno (Vigilancia Epidemiológica)	SALUS (SQL Server)	Vigilancia epidemiológica obligatoria solicitada por el Dr. Romano para reportes ministeriales y control asistencial: - Bronquiolitis en menores de 2 años (edad < 24 meses al momento de la consulta). - ETI (Enfermedad Ti	**Finalizado**
3. Bronquiolitis en Menores de 2 Años	SALUS (SQL Server)	Monitoreo mensual de casos de Bronquiolitis aguda en pacientes menores de 24 meses (< 2 años) atendidos en Guardia de Urgencias y Consultorios Pediátricos, solicitado para notificación epidemiológica ministerial y contro	**Finalizado**
4. Infecciones Respiratorias: ETI y Neumonía	SALUS (SQL Server)	Seguimiento sistemático de casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI / Gripe) y Neumonías (bacterianas, virales o adquiridas en la comunidad) para vigilancia de brotes respiratorios.	**Finalizado**
5. Gastroenteritis: Diarreas Agudas e Infecciosas	SALUS (SQL Server)	Detección y conteo de cuadros diarreicos y gastroenteritis agudas/infecciosas para la detección temprana de brotes hídricos o alimentarios requeridos por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.	**Finalizado**
6. Vigilancia de Varicela	SALUS (SQL Server)	Registro y seguimiento de casos de Varicela para control de inmunoprevenibles y seguimiento epidemiológico ministerial.	**Finalizado**

Indicador / Métrica	Origen de Datos (SALUS)	Definición Operativa y Regla de Cálculo	Estado
7. Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS / ITS)	SALUS (SQL Server)	Vigilancia de infecciones de transmisión sexual: Sífilis (precoz/tardía), Gonorrea, Clamidia, VIH, Herpes genital y Condilomatosis.	**Finalizado**

SANATORIO ARGENTINO

Innovación y Transformación Digital

Documento Técnico Oficial de Gobernanza de Datos Clínicos y Operativos. Todos los indicadores aquí documentados se encuentran auditados sobre la base de datos institucional SALUS y sincronizados con los tableros ejecutivos de gestión.